Tips del facilitador: Sala 1 · Trabajo de parto normal

Nov 10, 2026 · @ANDRES

Cómo usar esta guía

Este documento es una ayuda para el docente: preguntas para hacerles a los estudiantes en cada fase de la presentación, con la respuesta esperada y un tip clave. Pregunten antes de que toquen la opción en pantalla; la respuesta del grupo se discute y luego se confirma en la presentación.

Dato	Situación 1 · Valentina	Situación 2 · Camila
Edad / perfil	19 años, primigestante	34 años, multípara
FUM	8 feb 2026	2 feb 2026
EG por FUM (hoy 10 nov)	39 + 2 semanas	40 + 1 semanas
FPP (Naegele)	15 nov 2026	9 nov 2026
Fórmula obstétrica	G1 P0 A0 C0 E0 M0 V0	G4 P2 A1 C0 E0 M1 V1
Membranas	Íntegras	Rotas hace 1 h, líquido claro
Vía venosa	No tiene	Sí, lactato de Ringer
Apgar minuto 1	8	6
Oxitocina	10 UI intramuscular	10 UI intravenosa lenta

Tip general: que un estudiante lidere (quien atiende el parto), otro vigile a la madre y el monitor, y otro reciba al recién nacido. Al cambiar de fase, roten roles.

Preguntas y tips por fase

1. Ingreso

- ¿Qué significa cada letra de la fórmula? G gestas, P partos, A abortos, C cesáreas, E ectópicos, M mortinatos, V hijos vivos.

- En Camila, ¿por qué P2 si tiene un solo hijo vivo? Porque el mortinato de 38 semanas cuenta como parto y como M1.
- ¿Cómo calculan la EG por FUM? Días desde la FUM hasta hoy ÷ 7.
- ¿Cómo sale la FPP? Naegele: FUM + 7 días − 3 meses + 1 año.
- ¿La gestación es a término? Sí, ambas entre 37 y 41 + 6 semanas.

Tip: Camila ya pasó su FPP (9 nov). Pregúntenles si eso cambia la conducta: no, a 40 + 1 sigue siendo a término.

2. Trabajo de parto

- ¿En qué fase está a los 5 cm? Fase activa del primer periodo.
- ¿Qué se lee en el monitor? Dinámica uterina (frecuencia y duración en 10 min) y FCF.
- ¿Cuál es la FCF normal? 110 a 160 lpm.
- ¿Qué son las desaceleraciones que aparecen al final? Precoces: coinciden con la contracción por compresión de la cabeza; no indican sufrimiento.
- ¿Qué valoran en el tacto? Dilatación, borramiento, estación, membranas y presentación.
- Si rompen membranas, ¿qué registran? Hora, color y olor del líquido, y FCF inmediata.

Tip: pidan que digan la dilatación del simulador antes de abrir “Ver dilataciones”. En la multípara la dilatación avanza más rápido.

3. Expulsivo

- ¿Cuándo empieza el segundo periodo? Con la dilatación completa (10 cm).
- ¿Qué hace la mano de quien atiende? Controla la salida de la cabeza con la palma y protege el periné, sin traccionar.
- ¿Por qué no se hace presión en el fondo uterino (Kristeller)? Riesgo de desgarros, rotura uterina y trauma fetal.
- Después de la cabeza, ¿qué movimiento sigue? Rotación externa; luego hombro anterior y posterior.
- ¿Qué verifican al salir la cabeza? Circular de cordón.

Tip: que el estudiante diga en voz alta cada movimiento cardinal mientras lo hace en el simulador.

4. Recepción

- ¿Qué evalúa el Apgar y cuándo? FC, respiración, tono, irritabilidad y color, al minuto 1 y 5.
- Valentina: FC 140 (2), llanto vigoroso (2), alguna flexión (1), llora al estímulo (2), acrocianosis (1) = **8**.
- Camila: FC 110 (2), respiración irregular (1), alguna flexión (1), mueca (1), acrocianosis (1) = **6**.
- ¿Qué hacen con un Apgar de 6? Secar, estimular, posicionar la vía aérea y reevaluar; si no mejora, ventilar.
- ¿Por qué piel con piel? Termorregulación, vínculo e inicio de la lactancia.

Tip: la acrocianosis en el primer minuto es normal; no resta urgencia, pero sí un punto.

5. Pinzamiento

- ¿Cuándo se pinza el cordón en un bebé vigoroso? Pinzamiento tardío: entre 1 y 3 minutos o cuando deja de latir.
- ¿Qué beneficio tiene? Más reservas de hierro y mejor transición circulatoria.
- ¿Cuándo sería inmediato? Si el recién nacido necesita reanimación que no se puede dar con el cordón intacto.

Tip: en Camila el bebé llora a los 40 s tras estimularlo; pregúntenles si eso cambia el pinzamiento (no, ya respira).

6. Alumbramiento

- ¿Qué es el manejo activo? Uterotónico tras el nacimiento, tracción controlada del cordón y masaje uterino.
- ¿Cuál es el uterotónico de elección? Oxitocina 10 UI.
- ¿Por qué IM en Valentina e IV lenta en Camila? Valentina no tiene vía venosa; Camila sí.
- ¿Por qué no metilergometrina primero? Es de segunda línea y está contraindicada en hipertensión.
- ¿Por qué no terbutalina ni sulfato de magnesio? Relajan el útero (tocolítico) o son para preeclampsia; aumentarían el sangrado.
- ¿Qué revisan en la placenta? Que esté completa, membranas y cordón con 3 vasos.

Tip: la oxitocina IV nunca se pasa en bolo rápido: causa hipotensión.

7. Posparto

- ¿Qué vigilan en la primera hora? Tono uterino, sangrado, PA y FC cada 15 minutos.
- ¿Dónde debe estar el útero? Firme, a nivel o por debajo del ombligo.
- ¿Cuál es la primera causa de hemorragia posparto? Atonía uterina.
- ¿Cuándo inician la lactancia? En la primera hora, con el bebé piel con piel.

Tip: si el útero ya está firme, no se masajea de forma continua; se vigila.

Cierre (debriefing)

Dediquen los últimos 5 a 10 minutos de cada hora. Preguntas sugeridas:

1. ¿Qué salió bien en la atención de la madre y del recién nacido?
2. ¿En qué fase dudaron y por qué?
3. ¿Qué diferencias encontraron entre la primigestante y la multípara?
4. ¿Qué harían distinto si el Apgar al minuto 5 no mejorara?
5. ¿Qué signos del posparto los harían pensar en una hemorragia?

Mensajes clave para cerrar: FCF entre 110 y 160 lpm; no traccionar ni empujar el fondo uterino; pinzamiento tardío en el bebé vigoroso; oxitocina 10 UI en todo parto; vigilancia cada 15 minutos en la primera hora.